

## ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ЛИЗИНДА

**Препаратнинг савдо номи:** Лизинда

**Таъсир этувчи модда (ХПН):** -

**Дори шакли:** инфузия учун эритма тайёрлаш учун концентрат

**Таркиби:**

1 мл эритма қуйидагиларни сақлайди:

*фаол моддалар:* L-лизин гидрохлориди – 0,12 мг, натрий эсцинати- 0,88 мг.

*ёрдамчи моддалар:* этанол 96%, пропиленгликоль, инъекция учун сув.

**Таърифи:** тиниқ рангсиз суюқлик.

**Фармакотерапевтик гуруҳи:** Юрак-қон томир тизими. Ангиопротекторлар. Капиллярлар ўтказувчанлигини пасайтирувчи бошқа препаратлар.

**АТХ коди:** C05CX

### Фармакологик хусусиятлари

L-лизин яллиғланишга қарши, шишга қарши ва оғриқни қолдирувчи таъсир кўрсатади. Эсцин - сапонин, лизосомал гидролазалар фаоллигини пасайтиради, бу капиллярларнинг деворидаги ва уларнинг атрофидаги бириктирувчи тўқимадаги мукополисахаридларнинг парчаланишини олдини олади, ва шундай қилиб ошган томир-тўқима ўтказувчанлигини меъёрлаштиради ва экссудация (шиш) га қарши, яллиғланишга қарши ва оғриқни қолдирувчи таъсир кўрсатади. Препарат томирларнинг тонусини оширади, ўрта миёна иммунитетни тўғриловчи ва гипогликемик самаралар кўрсатади.

*L-лизин* – алмаштириб бўлмайдиган аминокислота. У организм томонидан ишлаб чиқарилмайди, овқат ёки қўшимчалар билан организмга тушади. Мушак оқсиллари ушбу аминокислотани сақлайди. Бу унинг спортда қўлланилишини асослайди. Препаратнинг хусусиятлари капиллярларни барқарорлаштирувчи воситалар гуруҳига тегишлидир.

Аминокислота оқсиллар асоси бўлиб хизмат қилади, тўқималар, айниқса мушакларнинг тикланишида, ўсишида ва ривожланишида иштирок этади. Ферментлар, антитаначалар, гормонларни ишлаб чиқаради, томирлар тонусини ва тўқималар ўтказувчанлигини оширади. Ўртача гипогликемик самарага эга. L-лизин иммунитетни мустаҳкамлайди, кальций ўзлаштирилишига ёрдам беради, мушакли тўқималар вазнини тез йиғилишини таъминлайди, пайларни чўзилиш ва узилишдан ва чўзилишидан ҳимоя қилади, тинкамадорни қуритадиган машқлар бажарилишидан кейин организмни тиклайди. L-лизинни жароҳатлардан кейин қўлланилиши жарроҳлик амалиётлари ўтказилишидан сақланишга ва тикланишни тезлаштиришга имкон беради.

### Фармакокинетикаси

Ўрганилмаган.

### Қўлланилиши

- жароҳатдан кейинги, жарроҳлик амалиёти ўтказилиши вақтидаги ва ундан кейинги турли жойлашувга эга шишлар: бош ва орқа миyaning оғир шишлари, шу жумладан бош мия ички қон қуйилишлари, бош мия ички босимининг ошиши ва шишиш-бўкиш кўринишлари;
- мия қон айланишининг сурункали ликвор-венозли бузилишлари ва вегетатив томирли дистонияси;
- қон билан таъминланишнинг маҳаллий бузилишлари ва оғриқ синдроми билан кечувчи таянч-ҳаракат апаратини жалб қилиниши билан юмшоқ тўқималарнинг шишлари;
- умуртқа поғонаси, тана, оёқ-қўлларнинг шишли-оғриқли синдромлари;

– шишиш-яллиғланиш синдроми билан бирга кечувчи ўткир тромбофлебитдаги оёқларнинг веноз қон айланишини оғир бузилишларида қўлланилади.

### **Қўллаш усули ва дозалари**

Препарат қатъий вена ичига аста-секинлик билан 5-10 мл ли суткалик дозада юборилади. (артерия ичига юборишга йўл қўйилмайди!). Вена ичига томчилаб юбориш тавсия этилади. Инфузион эритмани тайёрлашда препарат 50–100 мл 0,9% ли натрий хлориди эритмасида суюлтирилади.

Беморнинг ҳаётига хавф туғдирувчи ҳолатларда (ўткир бош мия жароҳати, жарроҳлик амалиёти ўтказилиши вақтидаги ва ундан кейинги бош ва орқа миyaning шишиш-бўкиш кўринишлари билан кечувчи шишлари, юмшоқ тўқималар ва таянч-ҳаракат аппаратининг кенг жароҳатлари оқибатидаги катта ўлчамли шишлар) суткалик доза 2 марта юборишга бўлиниб, 20 мл гача оширилади. Катталар учун максимал суткалик доза – 25 мл. Препарат кунига 2 марта юборилади.

Даволаш курсининг давомийлиги беморнинг ҳолати ва даволашнинг самарадорлигига қараб, 2 кундан дан 8 кунгача давом эттирилади.

### **Ножўя таъсирлари**

L-лизин ва эсцинга шахсий юқори сезувчанликда айрим беморларда қуйидагилар кузатилиши мумкин:

- *марказий ва периферик нерв тизими томонидан:* кам ҳолларда – бош оғриғи, бош айланиши, тремор;
- *жигар ва билиар тизими томонидан:* камдан-кам ҳолларда – трансаминазалар ва билирубин даражасининг ошиши;
- *меъда-ичак йўли томонидан:* кам ҳолларда – кўнгил айланиши, камдан-кам ҳолларда – қусиш, диарея, қорин оғриғи;
- *юрак қон-томир тизими томонидан:* кам ҳолларда – артериал гипотензия ёки артериал гипертензия, тахикардия, тўш орқасида оғрик;
- *нафас аъзолари томонидан:* камдан-кам ҳолларда – қуруқ йўтал;
- *аллергик реакциялар:* кам ҳолларда – тери тошмаси (папуллёз, петехиал, эритематозли), қичишиш, юз терисининг қизариши, иситма, эшакеми, санокли (бир нечта) ҳолларда – Квинке шиши, анафилактик шок;
- *маҳаллий реакциялар:* камдан-кам ҳолларда – юборишда вена йўллари бўйлаб ачишиш ҳисси, флебит, юбориш жойида оғрик ва шиш;
- *бошқалар:* камдан-кам ҳолларда – умумий ҳолсизлик, этни увишиши, қизиш ҳисси, терлаш кузатилиши мумкин.

### **Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар**

- L-лизин ва эсцинга ва/ёки препаратнинг таркибий қисмларига юқори сезувчанлик;
- буйраклар функциясининг оғир бузилишлари;
- жигар функциясининг оғир бузилишлари;
- ҳомиладорлик;
- эмизиш даври;
- 18 ёшгача бўлган болаларда қўллаш мумкин эмас.

### **Дориларнинг ўзаро таъсири**

L-лизин билан даволанишда бошқа дори воситалари (яллиғланишга қарши, анальгетиклар, микробларга қарши воситалар) ни мувофиқ кўрсатмалар бўйича буюриш мумкин.

Препаратни аминогликозидлар билан, уларнинг нефротоксиклиги ошиши мумкинлиги туфайли, бир вақтда қўллаш мумкин эмас. L-лизинни буюришдан олдин антикоагулянтлар билан давомли даволаш ўтказилган ҳолларда, ёки L-лизинни ва антикоагулянтларни бир вақтда буюришнинг зарурати бўлганида, охиргисининг дозасига тузатиш киритиш (дозани